

Livello 4 — Sintesi Tecnica

Psicologo di Base in Puglia — Studio Integrale HTA

Lo Psicologo di Base in Puglia — Sintesi Tecnica

Studio Integrale di Health Technology Assessment · L.R. 19 luglio 2023, n. 11 · Dott. Luigi De Michele · Puglia, giugno 2026

Destinatari: valutatori HTA, funzionari tecnici regionali e ministeriali, ricercatori. Livello 4 della piramide — quadro metodologico completo senza consultare il corpo integrale.

1. Scopo del documento e frase-tesi

Lo Psicologo di Base in Puglia produce un verdetto tripartito nettamente favorevole: nello scenario di copertura intermedio (775 professionisti), a un costo di 40,5 milioni di euro l'anno corrispondono 47,0 milioni di risparmi sanitari diretti e 27,0 milioni di benefici indiretti — un ROI (ritorno sull'investimento) lordo di 1:6,6 — con un costo per anno di vita guadagnato in buona salute di circa 9.800 euro, ben sotto le soglie di accettabilità correnti. Tre giudizi distinti — fiscale, sanitario, sociale — mai sommati in una cifra unica, ciascuno solido sul proprio piano.

Questo documento espone, senza richiedere la consultazione del Tomo I integrale, il quesito di valutazione, il telaio metodologico, la mappatura ai domini della valutazione di tecnologia sanitaria, il modello organizzativo, la metodologia economica con il relativo versioning, il protocollo dell'incertezza e i rimandi puntuali al corpo integrale. Non introduce contenuti nuovi: ricompone, a un livello di dettaglio intermedio, materiale già presente nel Tomo I.

2. Il quesito di valutazione e il mandato

Il mandato dell'opera discende dalla legge regionale 19 luglio 2023, n. 11, che ha istituito il Servizio di Psicologia di Base in Puglia — prima regione italiana a farlo. Poiché il servizio è già istituito per legge, il quesito di valutazione non verte sull'opportunità della sua esistenza, ma sulle conseguenze economiche e sociali del suo dimensionamento: quale livello di copertura adottare, e con quale sequenza attuativa.

Il quesito è scomposto secondo la grammatica standard della valutazione economica in sanità: popolazione di riferimento (i circa 3,89 milioni di residenti pugliesi, di cui tra 780.000 e 1.160.000 con disagio psichico comune clinicamente significativo), intervento valutato (il Servizio di Psicologia di Base, con relativa cascata di figure connesse), termine di confronto (lo status quo, senza Servizio strutturato), esiti considerati (fiscali diretti, sanitari, sociali indiretti), prospettiva dell'analisi (integrale ma articolata: bilancio sanitario regionale per le grandezze

dirette, società nel suo complesso per le indirette) e orizzonte temporale (valori annui di regime, con proiezione decennale nel modello di Markov, tasso di sconto 3%).

Riferimento al corpo integrale: Tomo I, Parte I, §1.1 «Scopo, mandato istituzionale e quesito di valutazione».*

**Il Tomo I contiene, non dichiarata nell'Avvertenza di edizione, una duplicazione di Parte I e Parte II (una versione breve, residuo di una bozza precedente, e una versione più estesa e sviluppata): questo e i successivi rimandi a "Parte I" e "Parte II" nel presente documento si riferiscono sempre alla versione estesa, già usata per costruire questa sintesi tecnica. Si veda `_meta/anomalie-corpus.md` per il dettaglio.*

3. Il telaio metodologico ibrido: quattro cornici apicali

L'opera non affida la valutazione a un'unica cornice metodologica, ma compone quattro tradizioni distinte e complementari, in una gerarchia funzionale in cui ciascuna cornice assolve una funzione specifica.

La valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) fornisce la griglia generale entro cui l'intero problema è ordinato, articolando l'analisi nei domini successivi descritti alla sezione 4.

Il modello dei cinque casi (Five Case Model), elaborato per la giustificazione degli investimenti pubblici nel Regno Unito, impone di argomentare congiuntamente cinque dimensioni: il caso strategico (coerenza con gli obiettivi di sistema), il caso economico (valore per la collettività), il caso commerciale (fattibilità dell'assetto contrattuale e organizzativo — si veda §9), il caso finanziario (sostenibilità di bilancio) e il caso gestionale (governance e gestione del rischio attuativo).

Lo standard internazionale di rendicontazione delle valutazioni economiche in sanità (della famiglia CHEERS) disciplina la trasparenza: prospettiva, orizzonte temporale, tasso di sconto, fonti dei parametri, metodi di trattamento dell'incertezza devono essere dichiarati esplicitamente. La compilazione puntuale della checklist CHEERS 2022 per l'intera opera è un'attività di conformità distinta, tracciata in `_meta/checklist-conformita.md`.

I criteri internazionali di valutazione delle politiche (rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, sostenibilità — di matrice OCSE-DAC) estendono lo sguardo oltre il piano economico, misurando l'aderenza della riforma ai bisogni documentati e la sua sostenibilità nel tempo.

Le quattro cornici costituiscono la parte invariante del telaio, comune allo studio pugliese e alla sua generalizzazione alle altre venti regioni italiane (Tomo II) e alla sezione UE-27: ciò assicura che studi alimentati da dati regionali diversi restino confrontabili perché generati dal medesimo procedimento.

Riferimento al corpo integrale: Tomo I, Parte I, §1.3 «Il telaio metodologico ibrido: le cornici apicali»; Appendice XVI ("Lo studio HTA regionale integrale — telaio HTA, Five Case Model, CHEERS 2022, criteri OCSE-DAC").

4. Mappatura ai nove domini dell'HTA Core Model (EUnetHTA)

Dominio	Trattazione nell'opera	Stato
CUR — Problema di salute e uso corrente	Parte II: quadro epidemiologico (transizione demografica, prevalenza dei disturbi mentali comuni, treatment gap, determinanti socioeconomici)	Completo
TEC — Descrizione tecnica dell'intervento	Parte IV: il modello organizzativo integrato; Parte III: architettura della cascata delle figure	Completo
SAF — Sicurezza	Trattata primariamente in relazione all'Intelligenza Artificiale (supervisione umana, AI Act) in Parte XIII, §13.3	Parziale — non è emerso un dominio di sicurezza clinica autonomo per l'intervento psicologico in sé (atteso, data la natura non farmacologica dell'intervento)
EFF — Efficacia clinica	Parte VI: base di evidenza sul modello di assistenza collaborativa (oltre 90 RCT internazionali)	Parziale — la Parte VI risulta, per dichiarazione interna dell'opera, sviluppata solo in parte rispetto alle altre 14 parti
ECO — Costi e valutazione economica	Parti VII–X: costi diretti, risparmi diretti, benefici indiretti, valutazione economica integrata	Completo, ma da riconciliare con l'ancoraggio OCSE 2026 (si veda §7)
ETH — Analisi etica	Parte XIII, §13.4: etica professionale e supervisione umana dell'IA	Completo
ORG — Aspetti organizzativi	Parte IV (modello organizzativo) e Parte XIV (attuazione, fattibilità e sostenibilità)	Completo
SOC — Aspetti sociali e del paziente	Parte IX: 16 domini multidisciplinari (lavorativo, pensionistico, welfaristico, criminologico, culturale, pedagogico, ecc.); Parte XII: equità	Completo
LEG — Aspetti legali	Parte XIII, §13.1–13.2: quadro costituzionale, convenzionale e normativo regionale/nazionale	Completo

Il dominio SAF e il dominio EFF risultano i meno sviluppati rispetto agli altri sette; questo squilibrio è annotato in `_meta/parking-lot.md` come area da rafforzare in una revisione futura, non colmata in questa fase per rispetto del congelamento dello scope.

5. Il modello organizzativo: la gerarchia piramidale

Il valore economico della riforma non origina da un'unica figura professionale, ma da una cascata gerarchica a cinque livelli, ordinata per influenza nel progetto e per capacità di rientro economico (diretto o

indiretto). Il principio previene la duplicazione: ogni effetto economico è attribuito al livello in cui si genera.

1. **Apice — Psicologo di Base.** Origine della cascata, massima influenza nel progetto. Capacità di rientro elevata ma indiretta: esercita il proprio valore attraverso le figure con cui opera. Dimensionamento: rapporto di copertura 1 ogni 4.400–4.900 abitanti, fabbisogno regionale a regime di 800–880 professionisti.
2. **Figure cliniche di primo contatto** — medico di medicina generale (coppia clinica nelle Case della Comunità, ritorno diretto e immediato su tre canali: farmaceutica inappropriata, PS/ricoveri, mobilità sanitaria), pediatra di libera scelta (ritorno prevalentemente preventivo, età evolutiva), neurologo (ritorno via appropriatezza diagnostica).
3. **Figure di continuità e filtro specialistico** — infermiere di famiglia e di comunità (care manager, continuità assistenziale), psichiatra consulente e Centri di Salute Mentale (filtro e razionalizzazione delle risorse specialistiche).
4. **Assistente sociale e servizio sociale territoriale** — presa in carico della dimensione sociale del disagio (domini welfaristico e assistenzialistico).
5. **Figure e ambiti extra-sanitari** — i restanti attori istituzionali ed extra-sanitari connessi ai 16 domini multidisciplinari di Parte IX.

L'Intelligenza Artificiale non costituisce un livello autonomo della cascata né un ambito a sé: è una leva trasversale, subordinata alla supervisione umana e al Regolamento (UE) 2024/1689, il cui contributo è isolato e non additivo rispetto al risparmio generato dal presidio professionale (10% del risparmio sanitario diretto per canale, nello scenario intermedio: 4,70 milioni di euro su 47,0 totali, ancoraggio OCSE 2026).

Riferimento al corpo integrale: Tomo I, Parte I, §1.2 «Il perimetro integrale e il principio ordinatore della gerarchia piramidale» e Parte III, da §3.1 in poi.

6. La metodologia della valutazione economica

Il nucleo della valutazione economica compone metodologie non alternative ma complementari, ciascuna specializzata in una grandezza determinata:

- **Analisi costo-beneficio (CBA)** — esprime in termini monetari costi e benefici, per il saldo e il rapporto beneficio/costo.
- **Analisi costo-efficacia/costo-utilità (CEA/CUA)** — rapporta i costi agli esiti clinici in unità naturali e agli anni di vita ponderati per la qualità (QALY), per il rapporto incrementale costo-efficacia (ICER).
- **Analisi di impatto di bilancio (BIA)** — stabilisce la sostenibilità per il bilancio sanitario regionale, anno per anno, per scenario di copertura.

- **Rendimento sociale dell'investimento (SROI)** — attribuisce un valore monetario agli esiti sociali (lavoro, carico familiare, benessere) e li rapporta alle risorse impiegate.
- **Modelli di Markov e microsimulazione** — proiettano il decorso clinico come successione di stati e transizioni lungo un orizzonte decennale (si veda §8).
- **Analisi decisionale multi-criterio** — compone dimensioni economiche, cliniche, etiche e organizzative non riducibili al solo costo.
- **Modelli di Kirkpatrick e Phillips** — valutano il ritorno sull'investimento formativo (Parte V) su cinque livelli, dalla reazione dei discenti al ROI finanziario.
- **Metodo del capitale umano e metodo del costo di attrito** — due approcci distinti e non cumulabili per la stima della produttività perduta.

La **regola di non duplicazione** è il presidio trasversale: nessun effetto è attribuito a più di una categoria, e le grandezze fiscali dirette restano sempre separate da quelle sociali indirette, senza sommarle in un'unica cifra (si veda il verdetto tripartito, §1 e §7).

Riferimento al corpo integrale: Tomo I, Parte I, §1.4 «Le metodologie innestate per la rinegoziazione», §1.5 «La rinegoziazione dei costi e dei benefici: tassonomia, confini, regola di non duplicazione», §1.6 «La batteria integrale di indicatori, variabili e parametri».

7. Il versioning dell'ancoraggio economico: da Chisholm 2016 a OCSE 2026

L'opera ha adottato inizialmente, come ancoraggio internazionale per il rendimento degli investimenti in salute mentale, gli intervalli di Chisholm e collaboratori (2016, *The Lancet Psychiatry*): 2,3–3,0 a 1 per i soli benefici economici, 3,3–5,7 a 1 includendo i ritorni di salute. Questo ancoraggio permane nel corpo del Tomo I (Parti VII–X) come "strato documentale della genesi dell'opera".

Una successiva **revisione metodologica di governo** ha sostituito questo riferimento con il framework OCSE (2026) — *The Economic Case for Preventing Mental Ill Health* — e con lo studio Unisanté-PLIMeC-P (NCT06377189, Università di Losanna), dichiarando esplicitamente che tali cifre prevalgono ovunque divergano dal corpo del volume. Il motivo della sostituzione è metodologico: Chisholm (2016) derivava le proprie stime in prevalenza da paesi a reddito medio-basso, con soglie di costo-efficacia non pertinenti al contesto europeo; il framework OCSE (2026) è calibrato sul setting delle cure primarie europee. Il moltiplicatore di revisione adottato è 1,375 per i canali farmaceutico, PS/ricoveri e mobilità, e 1,417 per il canale specialistico.

Indicatore (scenario intermedio, 775 psicologi)	Chisholm 2016	OCSE 2026
Costo di regime	40,5 mln €*	40,5 mln €
Risparmi sanitari diretti	34,0 mln €	47,0 mln €
ROI lordo	1:4,8	1:6,6
Costo/QALY	16.000 €	9.800 €
Break-even	3,2 anni	2,3 anni

**Il costo di 40,5 mln € è quello riportato dalla tabella di revisione per lo scenario intermedio; altre sezioni del Tomo I (Parte X) indicano una fascia di costo crescente con la copertura (43–47 mln € su 620/775/900 psicologi) non ancora riconciliata con questa tabella — si veda [_meta/status-tracker.md](#).*

Su decisione dell'autore (2026-07-06), i prodotti della piramide (Livelli 1–3 e questo Livello 4) adottano l'ancoraggio OCSE 2026 come autorevole.

La riconciliazione puntuale del calcolo dettagliato delle Parti VII–X del Tomo I con questo ancoraggio resta un'attività di editing (Fase 3, passata di verifica numerica) non ancora eseguita.

Riferimento al corpo integrale: Tomo I, "Revisione metodologica di governo — Il passaggio all'ancoraggio OCSE 2026" (sezioni IV.1–IV.6); Parte X, §10.5.5 «Il saldo consolidato: la tabella master e il verdetto complessivo» e "Quadro conclusivo economico-sociale e multidisciplinare integrale" per il calcolo su ancoraggio Chisholm 2016.

8. I tre scenari di copertura e il protocollo dell'incertezza

Lo studio valuta la riforma su tre scenari di copertura — denominati "conservativo/minimo" (620 psicologi), "intermedio" (775) ed "espansivo/pieno" (900) — a fronte di un fabbisogno prudenziale di 800–880 professionisti. Nell'ancoraggio OCSE 2026, i risparmi sanitari diretti passano da 23,5 milioni (scenario minimo) a 47,0 (intermedio) a 79,5 (pieno), con il costo per QALY che scende rispettivamente da circa 11.500 a 9.800 a 7.200 euro — in ogni caso ben al di sotto della soglia italiana di costo-efficacia (40.000 €/QALY, tre volte il PIL pro capite).

Il **protocollo dell'incertezza** (Parte XI) proietta questi risultati nel tempo e ne verifica la robustezza attraverso due strumenti complementari:

- **Il modello di Markov e la microsimulazione** rappresentano il decorso delle condizioni cliniche come successione di stati di salute e transizioni, su un orizzonte di dieci anni con tasso di sconto del 3%, utilizzando parametri invarianti cross-regionali (per il paziente tipo: risparmio di 1.304 euro, guadagno di 0,236 QALY).
- **L'analisi di sensibilità probabilistica (PSA)** sottopone i risultati a simulazione ripetuta su distribuzioni di parametri incerti, producendo una distribuzione dell'ICER con valore mediano coerente con la stima deterministica e una probabilità di costo-efficacia riportata nell'88,9% delle simulazioni (parametro invariante cross-regionale).

L'analisi è condotta per ciascuno dei tre scenari di copertura, che differiscono per numero di incarichi attivati e quota di popolazione intercettata.

Il protocollo dichiara inoltre **soglie di confutazione esplicite** ("previsioni falsificabili"): la conclusione di costo-efficacia muterebbe se l'efficacia clinica scendesse sotto una soglia dichiarata; la conclusione sul rendimento sociale muterebbe se i benefici indiretti cadessero fuori dalla fascia validata; la sostenibilità di bilancio è sottoposta a una soglia propria. Questa architettura di soglie, non il solo valore atteso, costituisce il presidio di robustezza del verdetto.

Riferimento al corpo integrale: Tomo I, Parte XI, in particolare §11.1 «Il modello di Markov e la microsimulazione», §11.2 «L'analisi di sensibilità probabilistica e gli scenari» e §11.7 «Le soglie che modificano la raccomandazione».

9. Attuazione, equità e profili etico-giuridici

Attuazione (Parte XIV). Il dispiegamento è scaglionato sulle sei Aziende Sanitarie Locali pugliesi, con reclutamento tramite elenco regionale e rapporto convenzionale — assetto già adottato da altre categorie professionali sanitarie. La governance è organizzata su due livelli (Osservatorio regionale; livello aziendale), con un registro dei rischi attuativi che include il rischio di reclutamento insufficiente come voce principale.

Monitoraggio (Parte XV). Il sistema di indicatori si fonda sul modello di Donabedian (struttura, processo, esito), con circa 58 misure in 8 categorie, protocollo di rilevazione attivo dal primo giorno, valutazione controfattuale d'impatto (differenza-nelle-differenze) e verifica ex post della regolamentazione secondo il metodo VIR (DPCM 169/2017) e la clausola valutativa regionale.

Equità (Parte XII). L'analisi distributiva valuta l'equità territoriale tra aree della regione, l'equità tra popolazioni e gruppi sociali, e l'equità di accesso legata alla leva digitale — quest'ultima rilevante per l'eventuale disparità di accesso a strumenti di IA a supporto del percorso di cura.

Profili etico-giuridici (Parte XIII). Il fondamento è costituzionale (art. 32 Cost.) e convenzionale (definizione OMS di salute, 1946); il quadro normativo regionale discende dalla L.R. 11/2023. Per l'Intelligenza Artificiale, il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) classifica i sistemi di ausilio diagnostico in ambito sanitario come sistemi ad **alto rischio** (Allegato III), con obblighi conseguenti di documentazione tecnica, fascicolo di conformità, gestione del rischio, supervisione umana, trasparenza verso i pazienti e registrazione presso l'EU AI Office. L'etica professionale e la supervisione umana restano principio governante, mai sostituito dall'automazione.

Riferimento al corpo integrale: Tomo I, Parte XII (equità e impatto distributivo), Parte XIII (profili etico-giuridico-organizzativi, §13.1–13.5), Parte XIV (attuazione, fattibilità e sostenibilità — integrata 2026-07-06), Parte XV (monitoraggio, valutazione ex-post e sintesi multidimensionale — integrata 2026-07-06).

10. Limiti dichiarati e agenda di consolidamento

1. I risparmi sanitari diretti, pur presenti nella letteratura di riferimento (Unützer et al., 2008), non hanno raggiunto significatività statistica se considerati isolatamente.
2. La Parte VI (efficacia clinica) risulta sviluppata solo in parte rispetto alle altre quattordici parti.
3. Il fabbisogno di personale (800–880 professionisti) dipende da un rapporto di copertura dichiarato come banda prudenziale, non come cifra puntuale; il reclutamento resta il principale rischio attuativo.
4. La revisione all'ancoraggio OCSE 2026 non è ancora riconciliata in modo puntuale con il calcolo dettagliato delle Parti VII–X, né risolve univocamente l'apparente incoerenza tra il costo di regime fisso riportato in Parte IV e la fascia di costo crescente con la copertura riportata in Parte X.
5. Il dominio SAF (sicurezza) dell'HTA Core Model non è sviluppato come dominio autonomo per l'intervento psicologico.
6. 111 delle 3.915 note a piè di pagina del Tomo I (2,8%) hanno corpo vuoto pur essendo regolarmente richiamate nel testo: il contenuto risulta perso in una fase antecedente a questa ristrutturazione (il file non è mai stato modificato durante le Fasi 3.1–3.3) e non è recuperabile dal solo file attuale. Elenco completo degli identificativi in `_meta/apparato-editoriale-tracker.md` (Fase 3.4, item 2bis).

Nessuno di questi limiti è stato colmato in questa fase, in ossequio al congelamento dello scope (§2.1 del prompt operativo): sono annotati per la Fase 2 (conformità) e Fase 3 (editing per passate tematiche).

11. Mappa dei rimandi al corpo integrale

- **Tomo I — Puglia** (tomo-1-puglia/opera-integrale-puglia.docx): Parti I–XV, come da tabella di stato in `_meta/status-tracker.md`; 33 Appendici Integrative con schema interno a 11 sezioni (telaio Five Case Model, Appendice XVI).
- **Tomo II — Nazionale, Linea A** (tomo-2-nazionale/opera-unificata-nazionale-e-ue27.docx): 20 volumi regionali individuali (Volumi 2–21), volumi metodologici (0.A, 0.B), sintesi nazionale (Volume 1), sezione UE-27 (Volume 22).
- **Tomo II — Nazionale, Linea B** (tomo-2-nazionale/blocco-regionale/tomo-ii-blocco-regionale.docx):
4 Blocchi Regionali macro-territoriali (Nord, Centro, Sud, Isole), con trattamento economico-organizzativo più esteso; relazione con la Linea A ancora da definire (si veda `_meta/status-tracker.md`).

- **Modelli tecnici** (`_meta/modelli-tecnici/`): workbook di tornado diagram, BIA, CEA/CUA, sensitivity analysis e Monte Carlo a supporto della documentazione tecnica riproducibile (buone pratiche ISPOR-SMDM — International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research / Society for Medical Decision Making — Task Force-7, sulla modellazione decisionale).

12. Abbreviazioni

Sigla	Espansione
AI Act	Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale
BIA	Budget Impact Analysis — analisi di impatto di bilancio
CBA	Cost-Benefit Analysis — analisi costo-beneficio
CEA	Cost-Effectiveness Analysis — analisi costo-efficacia
CHEERS	Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards
CUA	Cost-Utility Analysis — analisi costo-utilità
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
EUnetHTA	European Network for Health Technology Assessment
HTA	Health Technology Assessment — valutazione delle tecnologie sanitarie
ICER	Incremental Cost-Effectiveness Ratio — rapporto incrementale costo-efficacia
ISPOR-SMDM	International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research / Society for Medical Decision Making
OCSE-DAC	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico — Development Assistance Committee
OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità
PIL	Prodotto Interno Lordo
PSA	Probabilistic Sensitivity Analysis — analisi di sensibilità probabilistica
QALY	Quality-Adjusted Life Year — anno di vita ponderato per la qualità
ROI	Return on Investment — ritorno sull'investimento
SROI	Social Return on Investment — rendimento sociale dell'investimento
VIR	Verifica dell'Impatto della Regolamentazione

I nove domini dell'HTA Core Model (CUR, TEC, SAF, EFF, ECO, ETH, ORG, SOC, LEG) sono definiti direttamente nella tabella della sezione 4.

Per la sintesi narrativa si veda il Livello 3 (`_livelli-piramide/livello-3-executive-summary.md`); per il confronto tra opzioni di policy, il Livello 2 (`_livelli-piramide/livello-2-policy-brief.md`); per l'analisi integrale, il Tomo I.